

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

INVENTARIO DE PERSONALIDAD NEO REVISADO (NEO-PI-R)

Eje III: Personalidad • Modelo de Cinco Factores (FFM) y Evaluación Jerárquica de 30 Facetas

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Inventario de Personalidad NEO Revisado (NEO-PI-R, Forma S autoinforme).
Nombre Original	Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R; Costa & McCrae, 1992).
Autores Originales	Paul T. Costa, Jr., Ph.D. y Robert R. McCrae, Ph.D. (National Institute on Aging, NIH, EE.UU.).
Adaptación Hispana	Cordero, Pamos y Seisdedos (1999); Hogrefe TEA Ediciones (Madrid, España).
Eje Clínico y Constructo	Eje III: Personalidad. Estructura jerárquica pentafactorial (Big Five) y 30 facetas de personalidad.
Tipo de Instrumento	Autoinforme de 240 ítems graduados en escala Likert de 5 alternativas (0 = Total desacuerdo a 4 = Total acuerdo).
Población y Rango	Adolescentes (desde 16 años) y adultos. Ámbitos clínico, pericial-forense, psiquiátrico y laboral.
Tiempo de Administración	35 a 50 minutos de respuesta pausada y supervisada.
Régimen de Licencia	Comercial / Restringido. Propiedad de PAR / Hogrefe TEA Ediciones. Nivel C de cualificación psicométrica.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL MODELO DE CINCO FACTORES (FFM)

El **NEO-PI-R** representa la formulación operativa de referencia de la Teoría de los Cinco Factores (Five-Factor Model, FFM; Costa & McCrae, 1992, 2004). El modelo se sustenta en extensas investigaciones transculturales, factoriales y genético-conductuales que demuestran que la variabilidad de la personalidad adulta se organiza jerárquicamente en cinco dimensiones universales estables y con base biológica demostrada ($h^2 \approx 0.40 - 0.50$):

- Neuroticismo (N):** Tendencia disposicional a experimentar afecto negativo, hiperreactividad fisiológica al estrés, vulnerabilidad y labilidad afectiva.
- Extraversión (E):** Orientación proactiva hacia la interacción interpersonal, energía psicomotora, asertividad y propensión al afecto positivo.
- Apertura a la Experiencia (O):** Búsqueda e interés activo por vivencias y conceptos nuevos, sensibilidad estética, imaginación y flexibilidad intelectual.
- Amabilidad / Cordialidad (A):** Disposición prosocial fundamentada en empatía, confianza mutua, altruismo, modestia y actitudes de reciprocidad.
- Responsabilidad / Escrupulosidad (C):** Capacidad ejecutiva de autocontrol volitivo, organización metódica, disciplina, persistencia y deliberación.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS (30 FACETAS)

Cada uno de los 5 factores principales se desglosa en **6 facetas específicas** de 8 ítems balanceados (48 ítems por dominio; total = 240 reactivos):

Dominio Principal	Nº Ítems	Facetas Evaluadas (8 reactivos por cada subescala)
Neuroticismo (N)	48 ítems	N1: Ansiedad; N2: Hostilidad; N3: Depresión; N4: Ansiedad social; N5: Impulsividad; N6: Vulnerabilidad.
Extraversión (E)	48 ítems	E1: Cordialidad; E2: Gregarismo; E3: Asertividad; E4: Actividad; E5: Búsqueda de emociones; E6: Emociones positivas.
Apertura (O)	48 ítems	O1: Fantasía; O2: Estética; O3: Sentimientos; O4: Acciones; O5: Ideas; O6: Valores.
Amabilidad (A)	48 ítems	A1: Confianza; A2: Franqueza; A3: Altruismo; A4: Actitud conciliadora; A5: Modestia; A6: Sensibilidad a los demás.
Responsabilidad (C)	48 ítems	C1: Competencia; C2: Orden; C3: Sentido del deber; C4: Necesidad de logro; C5: Autodisciplina; C6: Deliberación.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO PSICOMÉTRICO EN ESPAÑA / LATAM

La baremación y validación española (Cordero et al., TEA Ediciones; $N > 3.000$) documenta una solidez psicométrica de referencia:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Factores	Alfa $\alpha = 0.86 - 0.92$	N ($\alpha = 0.90$), E ($\alpha = 0.88$), O ($\alpha = 0.87$), A ($\alpha = 0.86$) y C ($\alpha = 0.90$) en muestra española.
Consistencia Facetas	Alfa $\alpha = 0.60 - 0.84$	Consistencia adecuada para escalas breves de 8 ítems (mediana $\alpha = 0.73$).
Estabilidad Temporal	Test-retest $r = 0.80 - 0.88$	Elevada estabilidad a 6 meses y en seguimientos longitudinales a largo plazo.
Validez Estructural	CFA Pentafactorial	Confirmación de la estructura pentafactorial replicada en múltiples idiomas (CFI > 0.90).
Validez Convergente	$r = 0.50 - 0.72$	Altas correlaciones con escalas clínicas homólogas de MMPI-2, MCMI-III y TCI.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN, CONTROL DE VALIDEZ Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

- **Puntuación de Ítems:** Escala Likert de 5 alternativas: En total desacuerdo (0), En desacuerdo (1), Neutral (2), De acuerdo (3), Totalmente de acuerdo (4). Se invierten las claves indicadas según la plantilla oficial.
- **Cálculo Directo:** La suma de los 8 reactivos de cada faceta genera una Puntuación Directa (PD) de 0 a 32 puntos. La suma de las 6 facetas de un dominio genera la PD global del factor (0 a 192 puntos).
- **Control de Validez del Protocolo:**
 1. *Omisiones:* Protocolos con > 40 omisiones globales o > 6 omisiones en un único dominio se invalidan formalmente.
 2. *Aquiescencia y Negativismo:* Se contabiliza el total de respuestas de acuerdo (> 150 indica aquiescencia) y en desacuerdo (> 150 indica negativismo o disimulación defensiva).
 3. *Ítem de Verificación:* Ítem 240 final ("He respondido a todas las frases honesta y correctamente"). Si se contesta en desacuerdo, el protocolo se anula.
- **Conversión Normativa:** Las puntuaciones directas se transforman a **Puntuaciones T** (Media = 50, DT = 10) mediante baremos diferenciados por sexo y tramo etario (baremos general y clínico de TEA).

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	Rango T	Nivel del Rasgo	Relevancia Diagnóstica y Clínica
Muy Bajo	$T < 35$	Polo opuesto acentuado	Extrema inhibición o polo deficitario (ej. $N < 35$: frialdad / anestesia afectiva).
Bajo	$35 \leq T \leq 44$	Bajo el promedio	Tendencia clara hacia el polo inferior; modulación según contexto ambiental.
Medio / Típico	$45 \leq T \leq 55$	Población general	Zona de flexibilidad adaptativa; rasgos modulados sin rigidez estructural.
Alto	$56 \leq T \leq 65$	Rasgo elevado	Estilo de personalidad predominante; define pautas vinculares cotidianas.
Muy Alto	$T \geq 66$	Rasgo clínico extremo	Patrón inflexible y predominante; alta susceptibilidad a trastornos psiquiátricos.

ALERTA DE VULNERABILIDAD PSICOPATOLÓGICA (PERFIL $N \geq 65$ Y $C \leq 35$):

La presencia de Neuroticismo clínicamente alto ($T \geq 65$) junto con baja Responsabilidad ($T \leq 35$) y baja Amabilidad ($A \leq 35$) predice elevada refractariedad al tratamiento, desregulación de impulsos y alto riesgo de abandono precoz de intervenciones psicoterapéuticas ambulatorias.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA Y PLANIFICACIÓN PSICOTERAPÉUTICA

PROTOCOLO SECUENCIAL DE ENCUADRE TERAPÉUTICO GUIADO POR EL FFM:

- **Paso 1 (Evaluación de Estabilidad Afectiva - N):** Si Neuroticismo $T \geq 65$, priorizar técnicas de estabilización somática y regulación emocional antes de intervenciones cognitivas complejas o confrontativas. Inspeccionar N3 (Depresión) y N6 (Vulnerabilidad).
- **Paso 2 (Formación de Alianza de Trabajo - A y E):** Evaluar Amabilidad (A1 Confianza, A2 Franqueza). Si $A < 40$, estructurar el encuadre con acuerdos explícitos transparentes y evitar interpretaciones tempranas. En $E < 38$, regular la carga de estimulación terapéutica.
- **Paso 3 (Capacidad de Ejecución y Adherencia - C):** Si Responsabilidad $T \geq 55$, prescribir autorregistros y tareas estructuradas. Si $C < 38$, fraccionar las tareas en micrometas inmediatas para evitar deserciones y frustración.
- **Paso 4 (Selección del Enfoque Psicoterapéutico - O):** Si Apertura $T \geq 60$, el paciente responde favorablemente a técnicas narrativas, experienciales y metáforas; si $O < 40$, priorizar abordajes cognitivo-conductuales estructurados, directos y basados en solución de problemas.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: DESCOMPENSACIÓN DISTÍMICA Y DIFICULTADES VINCULARES

Identificación: Mujer de 34 años, arquitecta, derivada por medicina interna ante somatizaciones persistentes, desánimo crónico, aislamiento interpersonal progresivo y conflictos laborales severos por hipercrítica ("no soporto la lentitud de los demás").

Perfil Psicodiagnóstico NEO-PI-R (Línea Base):

- **Neuroticismo (N) = 71T** (Polo clínico extremo; N1 Ansiedad = 73T, N2 Hostilidad = 68T, N3 Depresión = 70T, N6 Vulnerabilidad = 66T).
- **Extraversión (E) = 36T** (Retraimiento social; E1 Cordialidad = 35T, E2 Gregarismo = 34T, E6 Emociones positivas = 32T).
- **Apertura (O) = 58T** (Interés intelectual; O2 Estética = 64T, O5 Ideas = 62T).
- **Amabilidad (A) = 33T** (Polo suspicaz y crítico; A1 Confianza = 31T, A2 Franqueza = 34T, A4 Actitud conciliadora = 30T).
- **Responsabilidad (C) = 72T** (Perfeccionismo rígido y sobreexigencia; C2 Orden = 70T, C3 Sentido del deber = 74T, C6 Deliberación = 68T).

Formulación e Intervención: Personalidad perfeccionista obsesivo-depresiva caracterizada por hiperresponsabilidad ($C = 72$) y suspicacia interpersonal ($A = 33$), generando sobrecarga laboral y desbordamiento depresivo reactivo ($N = 71$). Se aplicó Terapia Cognitivo-Conductual combinada con Terapia de Esquemas para flexibilizar esquemas de autoexigencia implacable y entrenamiento en comunicación asertiva.

Evolución y Reevaluación (10 meses): El Neuroticismo descendió a **53T**, la Hostilidad disminuyó notablemente y la Amabilidad ascendió a **44T**. La paciente logró delegar responsabilidades laborales y reanudó su red de apoyo social.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

VULNERABILIDAD AL SUICIDIO:

Neuroticismo $T \geq 70$ con faceta N3 (Depresión) $\geq 70T$ y N6 (Vulnerabilidad) $\geq 68T$ exige cribado urgente de ideación autolítica mediante protocolos clínicos específicos (BHS, C-SSRS).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLÍNICO:

La tríada $N \geq 65T$, $A \leq 35T$ y $C \leq 35T$ orienta hacia Trastorno Límite o Antisocial; mientras que $N \geq 65T$, $A \leq 35T$ y $C \geq 65T$ orienta hacia Trastorno Obsesivo-Compulsivo de la Personalidad.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

- Costa, P. T., Jr., & McCrae, R. R. (1992). *Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) professional manual*. Psychological Assessment Resources.
- Cordero, A., Pamos, A., & Seisdedos, N. (1999). *NEO PI-R: Inventario de Personalidad NEO Revisado. Manual*. TEA Ediciones.
- McCrae, R. R., & Costa, P. T., Jr. (2004). A contemplated revision of the NEO Five-Factor Inventory. *Language and Cognitive Processes*, 19(4), 587-596.
- Romero, E., Luengo, M. A., Gómez-Fraguela, J. A., & Sobral, J. (2002). La estructura de los rasgos de personalidad en niños y adolescentes según el modelo de los cinco factores. *Psicothema*, 14(3), 579-586.